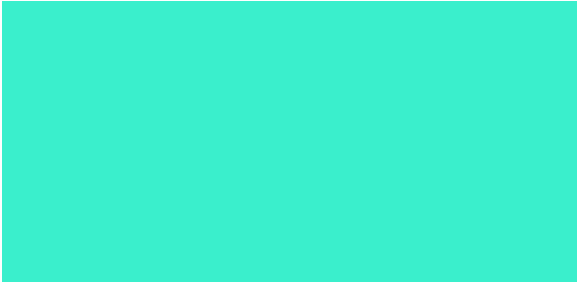




# **BOLI CU TRANSMITERE SEXUALA**



# AGENDA

**Sifilis**

**Gonoree**



Infectie urogenitala cu Chlamydia trachomatis

Infectie urogenitala cu mycoplasma genitalis

Infectie urogenitala cu ureaplasma urealyticum

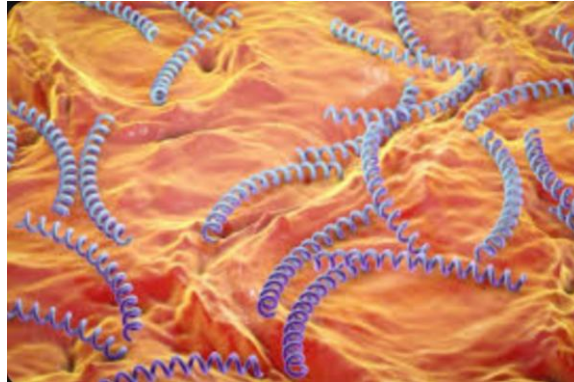
Trichomoniaza

# SIFILIS

# SIFILISUL

= Infecție care se transmite pe cale sexuală

- evoluție cronică și intermitentă care afectează mai multe organe: piele, inimă, vase sanguine, sistemul nervos, sistemul osos
- Agentul patogen al sifilisului este **Treponema pallidum**



Dimensiuni de 6-20  $\mu$

Formă spiralată cu 6-14 spire

Mobilitate crescută

Distrus de temperatura ambientală

# TRANSMITERE

- Sifilisul dobândit se transmite pe **cale sexuală**;
- foarte rar prin contactul pielii cu leziuni erozive cu secreții patologice sau sânge de la un bolnav cu sifilis
- prin transfuzii sanguine

Intrauterin/ la nastere  
(transmitere verticala)

# SIFILIS STADIALIZARE

## SIFILIS DOBÂNDIT

### A. Sifilis recent

1. sifilis primar
2. sifilis secundar
3. sifilis latent recent

### B. Sifilis tardiv:

sifilis latent tardiv

sifilis terțiar

## SIFILIS CONGENITAL

Sifilis congenital: precoce  
tardiv



# SIFILISUL PRIMAR

La 3 săptămâni după contactul infectant

La locul de inoculare



## Clinic:

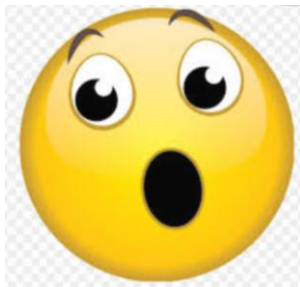
- eroziune/ leziune ulcerativă bine delimitată, rotund-ovalară, cu suprafață netedă, lucioasă (aspect lăcuit)
- Indurată la palpare
- Asimptomatică**

=

**Șancrul sifilitic**

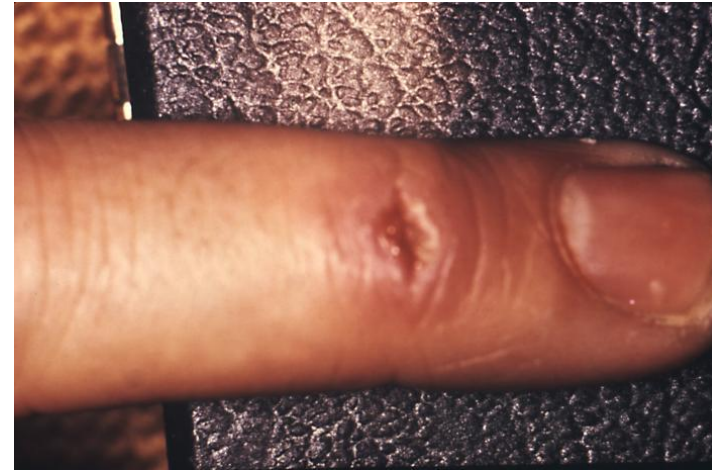
**Șancrul sifilitic se vindecă în absența tratamentului?**

**DA!**



Șancrul se epitelizează fără cicatrice în 4-6 săptămâni chiar și în absența tratamentului;  
Eventual, indurația poate persista mai mult timp (2-3 luni)

# SIFILISUL PRIMAR





# SIFILIS PRIMAR

Șancru primar + Adenopatie regională

## ***Adenopatia regională***

Apare în stațiile ganglionare din apropierea șancrului

Frecvent bilateral (exp: inghinal bilateral), poliganglionară

Nedureroasă, dură

Ganglionii sunt mobili

Este rezolutivă



# SIFILISUL SECUNDAR

După dispariția șancrului urmează o scurtă perioadă de latență, latența postprimară, până la apariția leziunilor din stadiul secundar

Boala devine sistemică în acest stadiu care începe după aproximativ **două luni** de la producerea infecției

Manifestările din perioada secundară se datorează trecerii treponemei în curentul sanguin după ce s-au multiplicat la nivelul sistemului limfatic

Leziunile: generalizate, superficiale și rezolutive **asimptomatice**



# SIFILIS SECUNDAR

## simptome generale:

cefalee cu caracter nocturn, difuză sau localizată

dureri osoase nocturne, dureri de tip nevralgic intercostale, brahiale, sciatic

modificări hematologice: leucocitoză cu limfopenie, anemie, VSH crescut

adenopatie generalizată: poliadenopatie cu ganglioni mici cervicali posterior, supraepitrochleeni, inghinali

# SIFILIS SECUNDAR-MANIFESTĂRI CUTANATE

(sifilide):

**Sifilide eritematoase:**

- prima erupție care apare în stadiul secundar **rozeolele sifilitice**: pete rotunde sau ovalare, roz, de 4-5 mm, nepruriginoase ce dispar la digitopresiune
- se localizează pe flancuri, fețele laterale ale toracelui, fața posterioară a axilelor

**sifilide papuloase și papulo-scuamoase:**

- sunt cele mai comune forme de sifilide și apar în luna a treia de evoluție, diseminate
- culoare roșie-arămie, formă rotundă, sunt infiltrate, 3-4 mm diametru, acoperite de o scuamă care se detașează central rămânând aderentă la periferie (gulerașul Biett)
- palmar și plantar → suprafața neteda, turtită

### **sifilide papulo-erozive:**

-au suprafața erodată și se localizează genital, perigenital, axilar, submamar

### **sifilide papulo-hipertrofice:** (condiloma lata) și au

-aceleași localizări ca și cele papulo-erozive

### **sifilide pigmentare:**

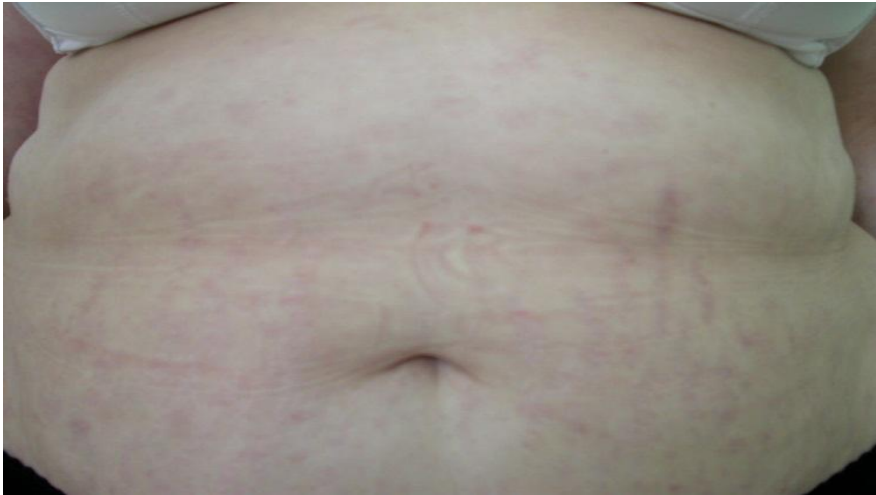
-apar după 6-8 luni de evoluție a infecției și au aspectul unei rețele hiperpigmentate cu zone depigmentate în ochiurile rețelei, cu localizare în jurul gâtului (“colierul Venerei”) și la nivelul regiunii frontale “coroana Venerei”

### **sifilide ulceroase:**

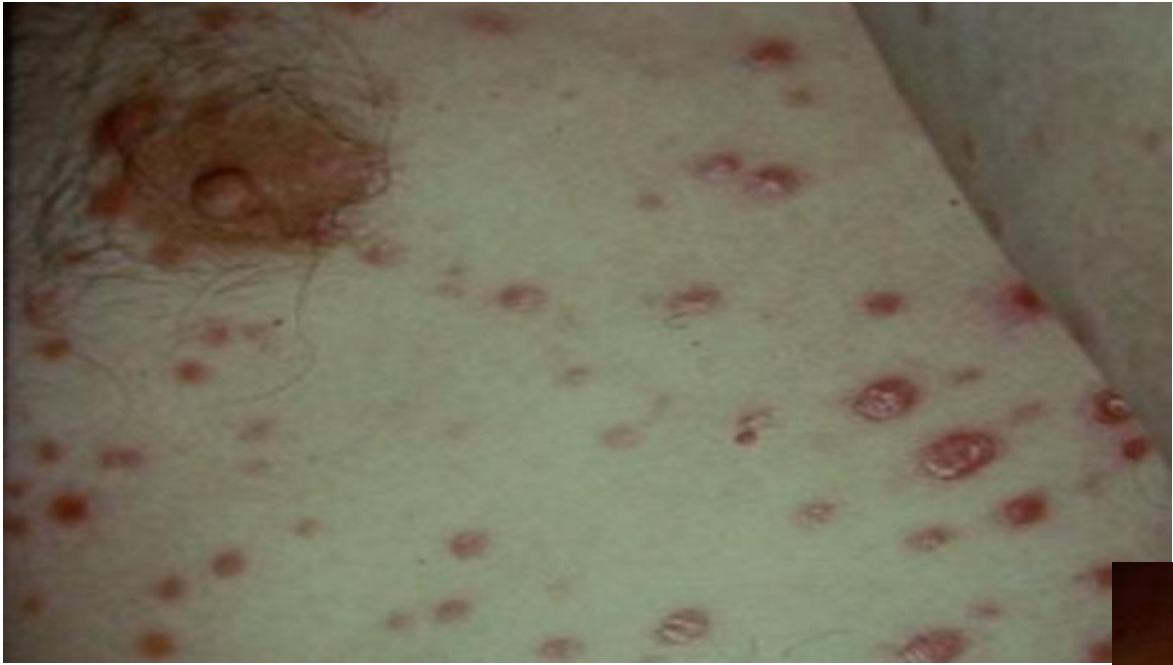
-ulcerații superficiale pe trunchi, membre cu aspect de ectimă

**Leziuni la nivelul mucoaselor:** bucală, genitală, faringiană, laringiană, nazală, anală: placi erodate, acoperite de depozit fibrinos

# SIFILIS SECUNDAR













# SIFILIS SECUNDAR

## Modificări ale anexelor pielii

la nivelul pielii capului: alopecie difuză sau insulară

alopecia părții externe a sprâncenelor

onixis și perionixis sifilitic

## Manifestări viscerale:

neurologice: meningită cu redoare, fenomene oculare

renale: nefroza sifilitică

hepatice: hepatită cu colestază

pleurale: pleurezie bilaterală

oculare: irită, keratită interstițială, nevrită optică

**Evoluția sifilisului** în acest stadiu se face pe parcursul a 2-3 ani, cu remisii ale leziunilor și recidive. În timp, leziunile se restrâng în suprafață, se grupează circinat, concentric sau corimbiform.

**Diagnostic diferențial al sifilisului secundar:** cu condiloamele acuminat, pitiriazis rozat Gibert, febrele eruptive, pitiriazis versicolor, lichen plan, prurigo, psoriazis.

# SIFILIS TERTIAR

După dispariția leziunilor din faza secundară urmează o perioadă de latență de mai mulți ani, de la 3-4 ani la 10-20 de ani

Răspunsul organismului la infecție este unul granulomatos determinat de o reacție imună tip IV

Leziunile terțiare: mai restrâns, sunt în număr limitat, asimetrice, sunt profunde, infiltrate, nerezolutive ducând la necroză și ulcerare

Leziunile terțiare sunt determinate de un proces de vasculită la nivel cutanat și la nivelul celorlalte organe care generează leziuni necrotice

# LEZIUNI CUTANATE SIFILIS TERTIAR

**tuberculi**, duri, de formă rotundă, culoare roșie-arămie, de 5-8 mm Ei se grupează în plăci și placarde de mărimi variabile, dispoziție inelară, arciformă, în buchet, cu evoluție excentrică, cu cicatrizare în partea centrală. Se localizează la față, pe trunchi, membre

**goma sifilitică**: unică sau multiplă, localizată mai ales pe membre dar și pe cap, torace, abdomen

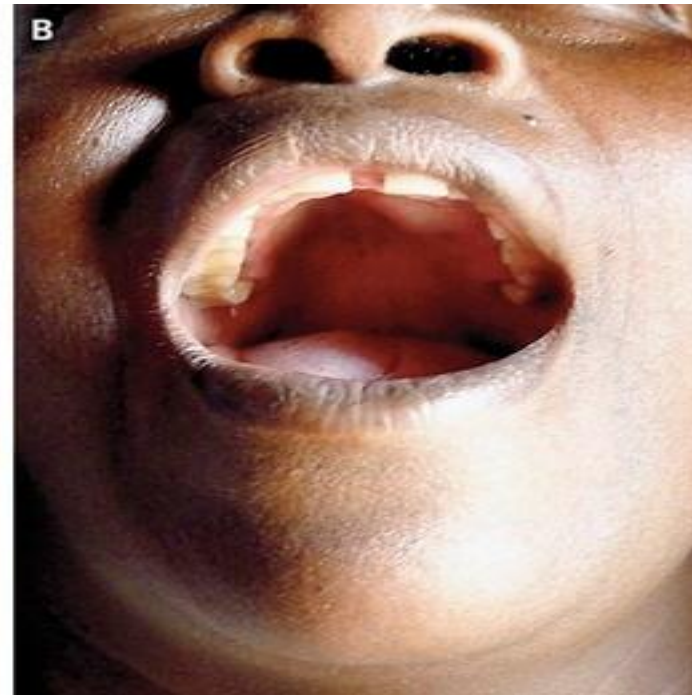
Trece prin mai multe stadii evolutive:

- nodozitate bine delimitată, dură, neinflamatorie, mobilă (stadiul de cruditătea);
- perioada de ramolire când devine roșie-violacee, fluctuantă și perioada de ulcerare când fistulizează în partea centrală, eliminând un lichid vâscos și țesut necrotic.
- Se transformă apoi într-o ulcerare rotundă, cu margini drepte, care se epitelizează prin cicatrice. Durează în general 3-4 luni

**goma sifilitică a limbii, glosita ulceroasă, glosita scleroasă, perforarea boltei palatine, sifilide terțiare amigdalene, ale buzelor**







# ALTE LEZIUNI SIFILIS TERTIAR

**Leziuni cardio-vasculare:** apar la 80% dintre pacienții netratați

- aorta:** anevrisme aorta ascendentă
- leziuni ale valvelor; regurgitare aortică
- Artere coronare (stenoze)
- Distrucții ale mușchilor papilari prin procesul gomos

**Leziuni osoase:**

- osteoperiostită plastică a oaselor lungi, osteoperiostită gomoasă și osteomielită gomoasă
- gome la nivelul tăbliei externe craniene
- gome la nivelul nasului

**Alte leziuni interne:**

gome la nivelul ficatului, **glandei parotide**, stomacului, testiculelor



# NEUROSIFILIS

cea mai gravă formă de sifilis, pacienți de vârstă tânără

Afectarea sistemului nervos central/periferic poate apărea în oricare din stadiile sifilisului (sifilis latent tardiv la care problemele neurologice pot fi foarte discrete)

- **neurosifilis parenchimatos** apare consecutiv invaziei țesutului nervos de către spirochete care determină leziuni distructive pe un teren cu imunitate redusă:

- paralizie generală: apare după 15-20 de ani de evoluție și are manifestări neurologice și psihiatrice care au la bază distrugerea cortexului cerebral

- tabes dorsal: sunt afectate coloanele posterioare din măduva spinării și rădăcinile dorsale; ataxie locomotorie progresivă, dureri fulgurante care apar brusc, radiază și dispar, parestezii, absența reflexelor tendinoase, ulcerații la nivelul picioarelor (mal perforant plantar)

- manifestări de afectare a nervilor cranieni: acustico-vestibular, facial, optic; paralizii de nervi prin leziuni gomoase și inflamatorii

- manifestări oculare: atrofie optică consecutivă nevritei, semnul Argyll-Robertson: anizocorie, pierderea reflexului la lumină

- **neurosifilis meningovascular**: manifestări ischemice, hemoragice, meningita acuta



În caz de suspiciune de Neurosifilis : puncție lombară și determinare VDRL și TPHA din LCR

- tulburări auditive: surditate, otoree cronică
- stigmat (sechele ale unor leziuni anterioare) cicatrici peribucale și distrofii: distrofii dentare (eroziuni coronariene, eroziuni cuspidiene, dinții Hutchinson), boltă palatină ogivală

## Sifilisul latent

absența oricăror manifestări clinice de sifilis în prezența infecției cu *T. Pallidum* dar cu teste serologice de sifilis pozitive

două forme: sifilis latent recent → vechime a infecției sub 2 ani (ultima serologie negativă) sifilis latent tardiv → peste 2 ani

Tratamentul este diferit în cele două forme

# Diagnosticul serologic al sifilisului

**VDRL**  
**TPHA**

# DIAGNOSTICUL SEROLOGIC AL SIFILISULUI

VDRL (venereal disease reagine laboratory)

- test de screening
- Reactie de floclulare
- Nespecifica
- Antigen: cardiolipina
- Pot exista reactii fals pozitive (sarcina, lupus eritematos sistemic, infectii virale, ciroza hepatica, consum alcool)
- Calitativ
- Cantitativ (titruri 1:2, 1:8, 1:16, etc) necesar pentru evaluarea raspunsului terapeutic

**TPHA** (treponema pallidum hemaglutinare)

-test de confirmare

VDRL si TPHA pozitive=sifilis confirmat

- **IgM** (ELISA)

- util in sifilisul congenital precoce

- diferenta: transfer pasiv de anticorpi sau infectie la nou-nascut

- util in stabilirea stadiului bolii (cazuri selectionate)



# Tratamentul sifilisului

**BENZATIN PENICILINĂ 2400000 UI IM**

# TRATAMENTUL SIFILISULUI

administrare de penicilină & adaptat stadiului și forme de boală:

**sifilis primar și secundar:** benzatin penicilină 2 doze a 2 400 000 UI i.m. la interval de o săptămână.

Tratament alternativ, procain penicilina

**Sifilisul latent recent:** 2 doze la interval de o săptămână de benzatin penicilină, a 2,4 milioane UI, i.m.

Tratament alternativ cu procain penicilină

**Sifilisul latent tardiv:** 3 doze la interval de o săptămână de benzatin penicilină, a 2,4 milioane UI, i.m.

Tratament alternativ cu procain penicilină

În neurosifilis tratamentul se face cu Penicilină cristalină, 20 000 000 UI pe zi, fracționată în 6 doze, timp de 15-20 de zile

În sifilisul congenital se administrează Penicilină G cristalină, 100 000 U/kgcorp/zi, 14 zile

În cazul alergiei la penicilină se poate administra tetraciclina, eritromicina

Este **obligatorie identificarea contactelor sexuali, a sursei infectante și tratarea concomitentă a acestora**

# GONOREEA

**Bărbat: uretrită acută**

2-6 zile după ctct sex neprotejat

Disurie, secreția purulentă galben-verzuie

Gland&șanț balano-preputial: eritem, edem

25% asimptomatici dar au „picătura matinală“

10% total asimptomatici

Gonoreea ascendentă→afectarea prostatei, epididim, etc.



## **Femeie: Cervicita si uretrita**

50% asimptomatice

Leucoree, disurie

Colul uterin friabil, sângerează la atingere

Bartholinita unilaterală

Ascensiunea catre endometru, salpinge → infertilitate, sdr inflamator pelvin



## **Gonoreea rectala: proctită**

durere, tenesme, constipatie (acuză „hemoroizi“)

tegument iritat, cu prurit, secreție purulentă

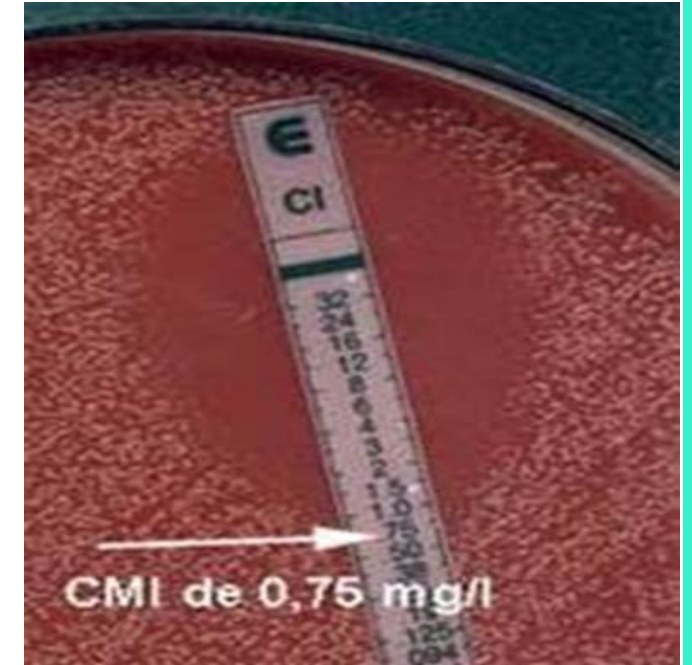
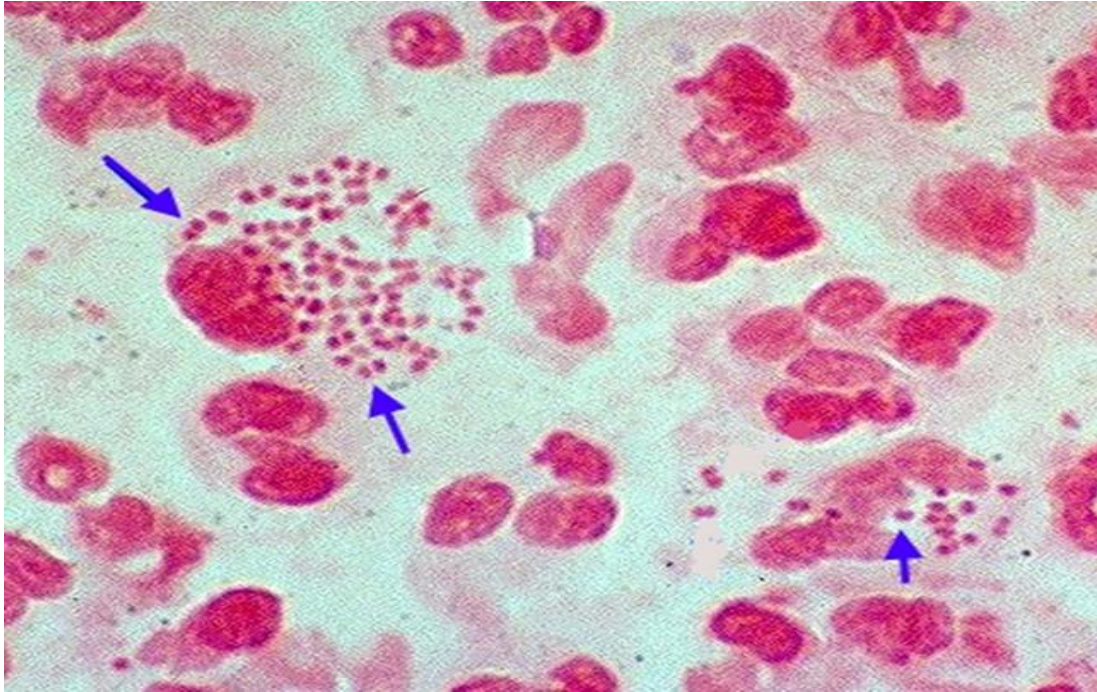
Proctoscopic: țesut friabil

50% contaminare (femeie) sau ctct sex. anal

**Gonoreea faringiană:** asimptomatică, rezervor de infecție. ! (ctct sex oral)



EX MICROSCOPIC COLORAT GRAM,  
CULTURI POZITIVE  
TESTARE SENSIBILITATE ATB  
NAAT (PCR)



# 2020 European guideline for the diagnosis and treatment of gonorrhoea in adults

M Unemo<sup>1</sup> , JDC Ross<sup>2</sup>, AB Serwin<sup>3</sup>, M Gomberg<sup>4</sup>, M Cusini<sup>5</sup>  
and JS Jensen<sup>6</sup> 

International Journal of STD & AIDS

0(0) 1–17

© The Author(s) 2020

Article reuse guidelines:

[sagepub.com/journals-permissions](https://sagepub.com/journals-permissions)

DOI: 10.1177/0956462420949126

[journals.sagepub.com/home/std](https://journals.sagepub.com/home/std)



## Abstract

Gonorrhoea is a major public health concern globally. Increasing incidence and sporadic ceftriaxone-resistant cases, including treatment failures, are growing concerns. The 2020 European gonorrhoea guideline provides up-to-date evidence-based guidance regarding the diagnosis and treatment of gonorrhoea. The updates and recommendations emphasize significantly increasing gonorrhoea incidence; broad indications for increased testing with validated and quality-assured nucleic acid amplification tests and culture; dual antimicrobial therapy including high-dose ceftriaxone and azithromycin (ceftriaxone 1 g plus azithromycin 2 g) OR ceftriaxone 1 g monotherapy (ONLY in well-controlled settings, see guideline for details) for uncomplicated gonorrhoea when the antimicrobial susceptibility is unknown;

**CEFTRIXONA 1G IM**  
**+**  
**AZITROMICINA 2G**

# ALTE BOLI CU TRANSMITERE SEXUALA

Infectii cu Mycoplasma (*Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma urealyticum*)

*Infectii cu Chlamydia trachomatis*

M – uretrita, epididimita, prostatita

F – cervicita, vaginita, salpingita

DOXICICLINA 2X1/zi 7 zile sau Azitromicina 1g

# ALTE BOLI CU TRANSMITERE SEXUALA

Trichomoniaza genitala- *Trichomonas vaginalis*

Vaginita nespecifica– *Gardnerella vaginalis*

Herpes cutanat

Hepatita C, Hepatita B

HIV

Scabie

**“THEY MAY FORGET  
WHAT YOU SAID, BUT  
THEY WILL NEVER  
FORGET HOW YOU  
MADE THEM FEEL.”**

**– Carl W. Buechner**

